

病人 / 家屬出現異常情緒或行為

① 第一線辨識 + 安全距離 + 安撫
(原步驟 1+2 合併)
• 30 秒內運用「眼耳鼻舌身意」評估
• 側身 45–90°，距離 1–2 公尺
• 保留逃生動線
• 平穩語調 + 同理話語

② CAB 風險評估
Cognition / Affect / Behavior

低風險
可有意義對談

③ 停聽同選 (CAB 低風險專用)
停 — 停下手邊的事
聽 — 傾聽病人需求
同 — 同理回應
選 — 合理範圍內提供選擇

是否穩定？
主觀是否感受到威脅？

升溫 / 感受威脅

④ 「叫」啟動團隊支援
(原步驟 3+4 合併，不分 Level)
• 通知同仁 / 單位主管 / 門診行政
• 啟動電腦緊急通報系統
• 按下緊急壓扣
• 電話通知駐警 / 保全
• 必要時報警 110

高風險
混亂無法對談
極端情緒 / 危險行為

⑤ 資源到達
護長 / 督導 / 駐警隊 / 行政

⑥ 場域秩序管控
• 行政：疏散民眾、降低圍觀
• 駐警：危險區域控制、安全警戒
• 醫護：盤點人員、確認約束裝備

⑦ 護長 / 督導
重新評估降階效果
(非第一線自評)

可降階

⑧ 高張情境降階五步驟
1. 確認後援、清除危險物品
2. 21 英呎法則、尊重個人界線
3. 建立關係 — 「我們是來幫你的」
4. 認可感受與需求、達成共識
5. 設下界線並提供選擇

是否穩定？

是

否

繼續升溫 / 已現威脅行為

⑨ 拉開距離 → 約束
• 拉大距離等候支援
• 駐警隊協助物理約束
• 必要時化學約束 (精神科支援)

⑩ 完成通報與紀錄
• 監視器 / 錄音 / 照片
• 受傷協助就醫、驗傷、筆錄
• 受理醫療暴力通知單 → 警局 + 衛生局
• 院內異常事件通報

⑪ 事後關懷與支持 (48 小時內)
• 主動關懷現場同仁
• 必要時轉介心理支持資源
• 召開團隊檢討會議
• 提升後續應變能力

結束